

RASTREAMENTO DE CÂNCER — RESUMO PRÁTICO

CONCEITO — RASTREIO x DIAGNÓSTICO PRECOCE

PRINCÍPIOS

- Rastreamento = aplicar teste a população ASSINTOMÁTICA para detectar a doença em fase pré-clínica
- Diagnóstico precoce = valorizar sinais/sintomas iniciais (não é rastreio)
- Equilíbrio benefício x dano: sobrediagnóstico, falso-positivo, complicações de exames/tratamento
- Há divergência entre INCA/MS (Brasil) e USPSTF/sociedades — conhecer ambas
- Cessação do tabagismo e vacinação (HPV) são prevenções PRIMÁRIAS de maior impacto

RESUMO — POPULAÇÃO E MÉTODO (referência BR/MS)

Câncer	Quem / idade	Método e intervalo
Colo de útero	25-64 anos, com vida sexual	Citologia (Papanicolau): 2 anuais; se negativas, a cada 3 anos (DNA-HPV incorporado ao SUS em 2024)
Cólon e reto	50-75 anos (AGA/USPSTF: a partir de 45)	FIT/sangue oculto anual OU colonoscopia; colonoscopia é o padrão-ouro/confirmatório
Próstata	Decisão compartilhada (homens; ~50-69)	PSA (± toque pela diretriz europeia); risco de sobrediagnóstico
Pulmão	50-80 anos, ≥ 20 maços-ano, fumante ou parou < 15 anos	TC de tórax de BAIXA DOSE anual (Lung-RADS)
Pele	Sem rastreio populacional	Diagnóstico precoce (regra ABCDE); acompanhar alto risco

COLO DE ÚTERO

PONTOS-CHAVE

- MS: 25-64 anos com vida sexual; 2 citologias anuais e, se negativas, a cada 3 anos
- NÃO rastrear < 25 anos nem quem nunca teve relação sexual (lesões NIC II em jovens regredem; risco de eventos adversos)
- USPSTF: 21-65 anos; 21-29 citologia 3/3 anos; 30-65 citologia 3/3 OU teste de HPV (ou co-teste) a cada 5 anos
- Suspende aos 64 anos se 2 exames negativos nos últimos 5 anos; após histerectomia total sem NIC II/III prévia, não rastrear
- Prevenção primária: vacina HPV (SUS: quadrivalente, 9-14 anos, dose única; resgate 15-19a)

CÓLON E RETO

PONTOS-CHAVE

- MS/INCA: 50-75 anos (risco habitual); incidência crescente em < 55 anos (AGA inicia aos 45; USPSTF: 45-49 recomendação B, 50-75 recomendação A)
- Métodos: análise de fezes (FIT/FIT-DNA, g-FOBT) OU endoscópicos (colonoscopia, sigmoidoscopia, colonoTC)
- Qualquer teste alterado -> COLONOSCOPIA (padrão-ouro)
- Alto risco (HF): iniciar 10 anos antes da idade do familiar mais novo afetado, ou aos 40 anos
- Suspende > 75-76 anos (individualizar); > 85 anos não rastrear

PRÓSTATA E PULMÃO

PONTOS-CHAVE

- PRÓSTATA: decisão COMPARTILHADA (benefício de mortalidade modesto x sobrediagnóstico alto). PSA é o método; biópsia se PSA > 4 (EUA) ou > 3 (Europa). USPSTF não recomenda toque retal de rotina
- Estratégias para reduzir dano: identificar grupos de risco, individualizar intervalo (PSA < 1 aos 40 / < 2 aos 60 -> adiar até 8 anos), RM/calculadoras antes de biopsiar, vigilância ativa em baixo risco
- PULMÃO: TC de baixa dose ANUAL em 50-80 anos com >= 20 maços-ano (fumante atual ou cessou < 15 anos) — reduz mortalidade (NLST/NELSON)
- Suspender se > 80 anos, > 15 anos sem fumar ou comorbidade que impeça cirurgia curativa; usar Lung-RADS
- No Brasil: cuidado com falsos-positivos por doenças granulomatosas (TB); cessação do tabagismo é a medida de maior impacto

PELE — NÃO HÁ RASTREIO POPULACIONAL

DIAGNÓSTICO PRECOCE

- Câncer de pele é o mais comum; não melanoma (basocelular/espinocelular) é o mais frequente; melanoma causa a maioria das mortes
- USPSTF: evidência INSUFICIENTE para rastreamento por exame da pele; MS reforça diagnóstico precoce
- Regra ABCDE para melanoma: Assimetria, Bordas irregulares, Cor heterogênea, Diâmetro > 6 mm, Evolução
- Alto risco (HF/pessoal de melanoma): acompanhamento periódico (INCA)
- Prevenção: fotoproteção; danos do rastreio amplo incluem biópsias desnecessárias e sobrediagnóstico

OUTROS RASTREIOS RELEVANTES (contexto)

PARA LEMBRAR

- Mama: mamografia (MS: 50-69 anos bienal; sociedades: a partir de 40)
- CHC: USG hepática semestral no cirrótico (ver apostila específica)
- Estômago/outros: sem rastreio populacional no Brasil (diagnóstico precoce e grupos de risco)
- Sempre individualizar por expectativa de vida e comorbidades
- Decisão compartilhada é central quando o benefício é incerto (próstata, pulmão)

CHECKLIST DE RASTREIO

NA PRÁTICA

- ☐ Colo: 25-64a, citologia (2 anuais -> 3/3 anos); vacinar HPV
- ☐ Cólon/reto: 50-75a, FIT anual ou colonoscopia; antecipar se alto risco
- ☐ Próstata: decisão compartilhada + PSA
- ☐ Pulmão: TC de baixa dose anual se >= 20 maços-ano (50-80a); ofertar cessação do tabagismo
- ☐ Pele: sem rastreio populacional — diagnóstico precoce (ABCDE) e seguir alto risco

MENSAGEM-CHAVE

RESUMO

- Rastrear a população e o intervalo certos; nem todo câncer se beneficia de rastreio populacional (pele/próstata = controvérsia)
- Conhecer as diferenças MS/INCA x USPSTF/sociedades
- Prevenção primária (vacina HPV, cessação do tabagismo) tem o maior impacto
- Individualizar por idade, comorbidades e preferências (decisão compartilhada)
- Teste de rastreio alterado -> exame confirmatório (ex.: colonoscopia)



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Segundo o Ministério da Saúde, qual a faixa etária e o método para rastreamento do câncer do colo do útero?

- A) Toda mulher a partir da menarca, com USG
- B) 25 a 64 anos com vida sexual, citologia (Papanicolau): 2 anuais e, se negativas, a cada 3 anos
- C) 18 a 70 anos, anual indefinidamente
- D) Apenas após os 50 anos
- E) Somente com teste de HPV a partir dos 21 anos

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o método e o intervalo recomendados para rastreamento de câncer de pulmão em pacientes de alto risco?

- A) Radiografia de tórax anual
- B) Tomografia de tórax de baixa dose anual (50-80 anos, ≥ 20 maços-ano, fumante ou cessou < 15 anos)
- C) Broncoscopia a cada 2 anos
- D) PET-CT anual
- E) Escarro citológico

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Sobre o rastreamento do câncer de próstata, é correto:

- A) Deve ser feito em todos os homens com toque retal obrigatório
- B) Envolve decisão compartilhada (PSA), pelo benefício de mortalidade modesto e alto risco de sobrediagnóstico
- C) Está formalmente recomendado para todos a partir dos 40 anos
- D) Usa USG transretal como rastreio primário
- E) Não há qualquer controvérsia

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual é a recomendação sobre o rastreamento populacional do câncer de pele?

- A) Exame de pele anual obrigatório para todos
- B) Não há benefício comprovado de rastreio populacional; foco em diagnóstico precoce (ABCDE) e seguimento de alto risco
- C) Dermatoscopia universal a partir dos 30 anos
- D) Biópsia de todas as lesões pigmentadas
- E) Rastreio apenas com exames de sangue

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual exame é o padrão-ouro e confirmatório no rastreamento do câncer colorretal?

- A) Sangue oculto nas fezes
- B) Colonoscopia
- C) Colonografia por TC
- D) Sigmoidoscopia isolada
- E) Enema opaco

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

MS: rastreio do colo entre 25 e 64 anos em quem já teve vida sexual, com citologia (Papanicolau) — 2 exames anuais e, se negativos, a cada 3 anos. Não se rastreia < 25 anos nem quem nunca teve relação sexual.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Rastreio de pulmão: TC de tórax de baixa dose ANUAL em 50-80 anos com ≥ 20 maços-ano, fumantes atuais ou que cessaram há < 15 anos (reduz mortalidade — NLST/NELSON). Cessação do tabagismo é a medida de maior impacto.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O rastreio de próstata é controverso: o benefício de mortalidade é modesto e o sobrediagnóstico é alto. Recomenda-se decisão compartilhada com PSA; USPSTF não recomenda o toque retal de rotina.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Não há benefício comprovado de rastreamento populacional do câncer de pele; o foco é o diagnóstico precoce (regra ABCDE para melanoma) e o acompanhamento de pacientes de alto risco.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A colonoscopia é o padrão-ouro do rastreio colorretal e o exame confirmatório: qualquer teste de fezes (FIT) ou outro método alterado deve ser seguido de colonoscopia.

SM24
Suporte ao Plantão Médico